

川崎町第10期計画 3層整合表（国基本指針→宮城県計画→川崎町計画）

—— 介護保険法第117条第3項の整合要請への対応 ——

1. 本整合表の目的

介護保険法第117条第3項は、市町村介護保険事業計画について「都道府県介護保険事業支援計画と整合性の確保された」ものでなければならないと規定しています。本整合表は、国基本指針（厚生労働省）・宮城県高齢者保健福祉計画・川崎町第10期計画の3層について、テーマ別マトリクスで整合性を確認し、ギャップがあれば対応を検討するための内部資料です。

2. シート構成

シート	内容	関連法令・指針
01_基本理念・基本目標	計画の基本理念・基本目標（6目標）の3層対応	介護保険法第117条第2項第1号
02_重点施策	5重点施策（移動・在宅・施設・包括・人材）の3層対応	介護保険法第117条第2項第2-5号
03_認知症施策推進計画	認知症基本法対応の7基本的施策の3層対応	認知症基本法第14条・第15-21条
04_介護保険サービス・保険料	サービス見込量・給付費・保険料の3層対応	介護保険法第117条第2項第2-3号
05_推進体制・KPI評価	推進体制・進行管理・評価の3層対応	介護保険法第117条第2項第6号
06_確認事項・論点	ギャップ・確認必要事項・対応方針の一覧	本整合表からの抽出

3. 整合性ステータス凡例

○ 整合	国・県・町の3層で方向性が一致しており、特段の対応不要
△ 部分整合	基本的に整合しているが、用語・KPI設定等に差異あり
? 要確認	県計画の最新版・国通知（R8夏以降）での確認が必要
× 未対応	国・県の方針に対し町計画で対応していない事項
★ 町独自	国・県には記載のない川崎町独自の取組（地域特性反映）

4. 出典・参照計画	
国	厚生労働省「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（介護保険法第116条）
国	認知症基本法（令和5年6月公布・令和6年1月施行）
宮城県	宮城県高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業支援計画（令和6-8年度）→ 第10期支援計画は令和8年度策定中
宮城県	宮城県認知症施策推進計画（令和6年度策定）
川崎町	川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 計画素案 v1.5（令和8年6月時点）
川崎町	川崎町第9期介護保険事業計画（令和6-8年度・基本理念踏襲元）

5. 注意事項
※ 宮城県第10期支援計画は令和8年度策定中のため、本整合表では第9期支援計画を参照し、第10期の方向性は推測値として記載しています。
※ 国通知（令和8年夏以降）の内容により、整合性ステータスが変更される項目があります。Ver.2.0で更新します。
※ 「△部分整合」「?要確認」「×未対応」の項目は、06_確認事項・論点シートで対応方針を整理しています。
※ 本整合表は事務局用内部資料です。委員会では06シートを抜粋して参考資料として提示することを推奨します。

01 基本理念・基本目標の3層整合

■計画の根幹となる基本理念・基本目標について、国・県・町の3層で対応関係を確認

No	項目・テーマ	【国】基本指針の方向性	【宮城県】計画の方向性	【川崎町】本計画の対応	整合性	備考・根拠
【基本理念】						
01-1	基本理念	深化・推進」を基本指針として推進。すべての高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるまちづくりを推進。	宮城県計画では「いざいざりと心豊かに健やかに暮らせる長寿社会」を基本理念とし、地域包括ケアシステム深化を推進。	安心して暮らせるまちづくり」（第9期踏襲）＋認知症基本法対応サブタイトル「～認知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域づくり」を基本目標として明示。	○ 整合	国・県の基本指針と町の理念は方向性一致。サブタイトル付加は協議事項 ¹ で審議。
【基本目標体系】						
01-2	基本目標1 健康づくり・介護予防	介護予防・健康寿命延伸を重点。フレイル予防・通いの場の充実を推進。	県計画でも介護予防・フレイル予防・健康寿命延伸を基本目標として明示。	基本目標1として継承。ユニバーサルサポーター制度（14種別約400名）等の町独自施策を含む。	○ 整合	国・県と整合。町独自のサポーター制度は強みとして記載。
01-3	基本目標2 まちづくり・地域支援	地域共生社会の実現、生活支援体制整備を推進。	県計画でも地域支援・見守り・生活支援を基本目標として位置付け。	基本目標2として継承。移動支援3層構造の整理を新規の重点要素として追加。	○ 整合	町独自の移動支援3層構造（タクシー助成終了後の対応）は地域特性反映。
01-4	基本目標3 在宅生活継続支援	在宅医療・介護連携、家族介護者支援を重点。レスパイト体制の整備。	県計画でも在宅医療介護連携、家族介護者支援、レスパイトを基本目標。	基本目標3として継承。8050問題・老老介護対応、介護離職防止支援を強化。	○ 整合	8050問題は全国共通課題。介護離職防止は第9期から強化。
01-5	基本目標4 サービスの質・提供体制	介護サービスの質確保、人材確保・育成、ICT・介護ロボット導入推進。	県計画でも介護人材確保（修学資金貸付制度等）・サービスの質を基本目標。	基本目標4として継承。町外施設利用（住所地特例24人）・広域連携の検討を含む。	○ 整合	町外施設利用は本町特有の課題。広域連携で対応。
01-6	基本目標5 地域包括ケアシステム深化	地域包括ケアシステムの深化・推進、地域包括支援センター機能強化を重点。	県計画でも地域包括ケアシステム・包括センター強化を基本目標。	基本目標5として継承。包括センター体制（社協運営・保健師3＋認定調査1）の強化を明示。	△ 部分整合	包括センター体制強化は財政事情を勘案。県のモデル事業活用も検討。

01-7	基本目標6 認知症施策（新設）	認知症基本法対応として、認知症施策の総合的推進を基本指針に明示（令和6年1月以降）。	県計画は令和6年度策定の認知症施策推進計画と連動。	基本目標6として新設、第6章独立章化（協議事項2）。	○ 整合	認知症基本法第14条対応。3層で新設方向で一致。
------	--------------------	--	---------------------------	----------------------------	------	--------------------------

02 重点施策の3層整合（移動・在宅・施設・包括ケア・人材）

■5つの重点施策（J-A～J-E）について国・県・町の3層対応を確認

No	項目・テーマ	【国】基本指針の方向性	【宮城県】計画の方向性	【川崎町】本計画の対応	整合性	備考・根拠
【J-A：移動支援3層構造の確立】						
02-1	移動支援の方針	高齢者の移動手段確保、外出支援・買物支援を地域支援事業で推進。	県計画でも移動支援・買物支援を地域づくりの一環として推進。	（R7.3）→社協NPO移送・デマンドバス・町民バスの3層構造に移行。住民周知の一元化と所管調整を重	★町独自	本町の独自の3層構造。所管が複数（地域振興課・町民生活課・社協・NPO）。
02-2	公共交通との連携	公共交通機関との連携、地域公共交通計画との整合を推奨。	県でも市町村地域公共交通計画との連携を推奨。	町民バス・デマンドバスは町地域振興課・町民生活課所管。福祉部局と継続協議。	△部分整合	町内では福祉部局と交通部局の連携が課題。委員会協議事項3で取り上げ。
【J-B：在宅医療・介護連携と家族介護者支援】						
02-3	在宅医療・介護連携	在宅医療・介護連携推進事業（地域支援事業）を推進。	県計画でも在宅医療介護連携、市町村への支援を推進。	国保川崎病院を町内拠点とし、広域医療機関（県南中核病院・刈田総合）と連携。在宅医療・介護連携推進事業を継続実施。	○整合	国保川崎病院の存在が本町の強み。
02-4	家族介護者支援・介護離職防止	家族介護者支援、レスパイト体制、介護離職防止を推進。	県計画でも家族介護者支援・介護離職防止を基本目標として位置付け。	家族介護教室・短期入所活用・8050問題・老老介護対応を強化。介護離職防止は新規取組として検討。	○整合	8050問題対応は重層的支援体制（地域福祉計画と連動）。
【J-C：施設サービス・町外連携】						
02-5	施設サービス見込量	サービス見込量を将来推計（人口・認定率・利用率・利用量）で算定することを規定。	県計画でも見える化システムによる比較・整合確認を推奨。	町外施設利用（住所地特例24人・R7.6）を含めた見込量算定。第7章 7-1 6ステップで実施。	○整合	本町は施設縮小傾向で町外依存。広域連携で対応。
02-6	介護人材確保	介護人材確保・育成支援、ICT・介護ロボット導入支援を推進。	県計画でも介護人材確保（宮城県社協 修学資金貸付制度等）・処遇改善・ICT導入を推進。	町内事業者連絡会を通じた人材実態把握、修学資金貸付の周知、ICT導入支援検討。	△部分整合	本町独自の人材確保策は限定的。県事業の活用が中心。

【J-D：地域包括ケアシステム深化】

02-7	地域包括支援センター強化	地域包括支援センター機能強化、3職種（保健師・社会福祉士・主任ケアマネ）確保、認定調査体制整備。	県計画でも包括センター機能強化、人材確保を基本目標。	保健師3+認定調査1名（社協運営）の体制。第10期で認定調査員増員検討、ICT導入で業務効率化。	△部分整合	町としては財政負担を勘案。県のモデル事業活用も検討。
02-8	自立支援型地域ケア会議	自立支援型地域ケア会議の開催、多職種連携の促進を推進。	県計画でも自立支援型地域ケア会議の充実を推進。	包括センター主催で継続実施。第10期では多職種連携（医療・介護・地域）の深化を重点化。	○整合	本町は会議開催実績あり。質的向上が課題。

【J-E：広域医療連携】

02-9	広域医療連携	在宅医療・介護連携の充実、医療機関・介護事業者の連携強化。	県計画では仙南二次医療圏（柴田・大河原・川崎・村田・蔵王・七ヶ宿）での広域連携を推進。	みやぎ県南中核病院（大河原）・刈田総合病院（白石）等との連携。国保川崎病院をハブ化。	★町独自	町外医療機関への通院常態化。仙南二次医療圏内連携。
02-10	認知症医療連携	認知症疾患医療センターとの連携、早期発見・治療フォローを推進。	県計画では認知症疾患医療センターと地域包括の連携を推進。	国保川崎病院+認知症疾患医療センター（仙南圏域）の連携で早期発見・治療フォロー。	○整合	本町は認知症診断・治療を国保川崎病院+広域連携でカバー。

03 認知症基本法対応 7基本的施策の3層整合

■認知症基本法第15条～21条の7基本的施策について国・県・町の3層対応を確認

No	項目・テーマ	【国】基本指針の方向性	【宮城県】計画の方向性	【川崎町】本計画の対応	整合性	備考・根拠
【認知症基本法 7基本的施策】						
03-1	第15条 普及啓発	認知症の本人と家族・地域住民への普及啓発、認知症サポーター養成。	県認知症計画でもサポーター養成・キャラバンメイト養成、啓発活動を推進。	サポーター養成講座継続（累計550名）、キャラバンメイト73名、企業・学校サポーター拡大。J-1として重点化	○ 整合	本町のサポーター養成累計550名は県平均水準を上回る。
03-2	第16条 共生社会の実現	認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって生活できる地域づくり、共生社会の実現。	県計画でも共生社会・地域づくりを基本理念。	知症になっても誰もが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現～」(協議事項1)。基本理念として明示	○ 整合	サブタイトル付加は協議事項1。委員意見次第。
03-3	第17条 社会参加機会の確保	認知症の人の社会参加機会、本人ミーティング・地域活動参加を推進。	県計画でも本人ミーティング・社会参加を推進。	認知症カフェ「喫茶みかん」継続＋本人ミーティング新設（J-3）。認知症本人による情報発信を検討。	○ 整合	本人ミーティング新設は本町でも新規取組。第10期で立ち上げ。
03-4	第18条 保健医療福祉提供体制	認知症疾患医療センターとの連携、認知症地域支援推進員配置、初期集中支援チーム整備。	県計画でも認知症疾患医療センター（仙南圏域）との連携を推進。	稼働中、地域支援推進員配置、国保川崎病院＋認知症疾患医療センター（仙南圏域）連携。J-4・J-5として	○ 整合	本町は早期発見・支援体制が整備済み。質的向上が課題。
03-5	第19条 研究開発	認知症の研究開発、データ収集を推進。	県計画でも認知症データ収集・調査を推進。	町計画では直接対応の取組なし。県・国レベルの研究へのデータ提供等で連携。	○ 整合	市町村レベルでの直接的な対応は限定的。県と連携。
03-6	第20条 認知症の人を支える人材	認知症ケアの専門人材育成、家族介護者支援、サポーター・チームオレンジ整備。	県計画でもチームオレンジ整備の市町村支援を推進。	チームオレンジの新規整備（J-2・本町未整備）、家族介護教室、サポーターの質的向上。	× 未対応	現在チームオレンジ未整備。第10期で整備計画・人員確保が課題。
03-7	第21条 その他の施策（権利擁護・安全等）	成年後見制度の利用促進、虐待防止、行方不明者対応等の認知症関連施策。	県計画でも成年後見制度利用促進・虐待防止を推進。	成年後見制度利用支援（任協日常生活自立支援事業含む）、高齢者虐待防止対応、行方不明者捜索のSOS体制	○ 整合	本町は社協日常生活自立支援事業を活用。

【KPI設定の整合】					
03-8	KPIの3層構造	国推奨：プロセス（活動量）・アウトプット（成果物）・アウトカム（住民変化）の3層KPI。	県計画でも3層KPI（特にアウトカム）の設定を推奨。	第10期で3層KPI採用（J-1～J-5各重点施策）。アウトカム指標「認知症本人と家族の地域生活満足度」を新設	○整合 本町は第10期で初の3層KPI採用。アンケートで測定。
03-9	認知症本人・家族の意見聴取	認知症基本法第14条第6項：計画策定時に本人・家族意見の反映を求められる。	県計画でも本人・家族意見の聴取・反映を推奨。	包括センター・国保川崎病院・認知症カフェの3チャネルで意見聴取。郵送アンケートと並行。	○整合 認知症基本法対応として本町でも初の取組。

04 介護保険サービス見込量・給付費・保険料の3層整合

■サービス見込量・給付費・保険料試算の枠組みについて国・県・町の3層対応を確認

No	項目・テーマ	【国】基本指針の方向性	【宮城県】計画の方向性	【川崎町】本計画の対応	整合性	備考・根拠
【サービス見込量】						
04-1	見込量算定方法	国基本指針：人口推計（社人研）・認定率・利用率・1人当たり利用量で算定。	県計画では見える化システムによる算定支援・比較確認を推奨。	第7章 7-1で6ステップ算定（人口推計→認定者推計→利用率→見込量推計→アンケート補正→見える化登録）	○ 整合	国推奨方法に準拠。見える化システム活用予定。
04-2	町外施設利用の反映	サービス見込量は実態に基づく算定を求める（町外利用も含む）。	県計画でも市町村間の利用実態を考慮した算定を推奨。	住所地特例24人（R7.6）を含めた見込量算定。広域連携の検討。	★ 町独自	本町は町外施設依存度が比較的高い。具体的内訳の把握が第10期で重要。
04-3	地域支援事業の上限管理	地域支援事業費の上限額管理を規定。	県計画でも上限額管理を推奨。	R3実績3,207万円。第10期は包括センター強化・認知症基本法対応で上方圧力あり。上限内で実施。	○ 整合	本町は上限内で運営。
【保険料試算】						
04-4	保険料算定方法	算定（標準給付費→地域支援事業費→第1号負担分→調整交付金→財政安定化基金償還→基金取崩→収納必	県計画では市町村への算定支援。県内自治体の保険料水準比較も提供。	第7章 7-3で8ステップ準拠の算定。基金取崩額により3パターン（A:なし/B:50%/C:全額）試算。	○ 整合	国推奨8ステップに完全準拠。
04-5	所得段階区分	国推奨：9段階から13段階への見直し。最低0.455～最高2.40の保険料率。	県計画でも市町村への13段階化推奨。	第10期で13段階化検討（協議事項5）。所得段階別R3末3,255人（第5基準697人）。R3総合収納率96.3%・現年度99.0%・特別徴収100.0%。第10期予定収納率はR8.6町確認後確定	○ 整合	本町でも13段階化検討中。具体的影響額は第3回委員会で精緻化。
04-6	予定収納率	国基本指針：過去5年間の収納率実績の平均を使用。	県計画でも収納率の維持向上を推奨。		? 要確認	過去5年実績の集計が町確認待ち。

04-7	介護給付費準備基金	保険料抑制のため基金取崩を許容。	県計画でも基金活用の方 向性を提示。	基金残高R8.6時点確定 値で3パターン試算。第3 回策定委員会（R9.1）で 精緻化。	? 要確認	基金残高の確定値（R8.6 時点）が町確認待ち。
【給付費見込み】						
04-8	給付費上昇要因	国基本指針：後期高齢者 増加・認知症対応強化等 により給付費上昇傾向と 認識。	県計画でも全県的に給付 費上昇を予測。	R3給付費9.61億円（保 険給付費総額10.4億円）。 R7.6時点で後期高齢者 +18.2%増。第10期は上 方圧力あり。	○ 整合	本町は宮城県内でも高齢 化率上位（5位・41.4%）。

05 推進体制・進行管理・KPI評価の3層整合

■計画の推進体制・PDCAサイクル・評価の枠組みについて国・県・町の3層対応を確認

No	項目・テーマ	【国】基本指針の方向性	【宮城県】計画の方向性	【川崎町】本計画の対応	整合性	備考・根拠
【推進体制】						
05-1	策定委員会の設置	国基本指針：被保険者・被保険者の意見を反映するため、市町村介護保険事業計画策定委員会等の設置を推奨	県計画でも策定委員会設置を全市町村に推奨。	川崎町高齢者保健福祉計画策定委員会を設置。R8.8～R9.2で計4回開催予定。	○ 整合	策定委員会は本町でも例規に基づき設置。
05-2	本人・家族意見の反映	認知症基本法第14条第6項：認知症本人・家族意見を反映。介護保険法でも被保険者意見の反映を求める。	県計画でも本人・家族意見を反映を推奨。	アンケート1,300名（一般1000+認定者300）、認知症本人・家族意見は包括・国保川崎病院・認知症カフェの3チャネル	○ 整合	本人意見聴取は本町でも基本法対応として初の取組。
05-3	計画策定プロセスの透明性	国基本指針：策定プロセスの公開、パブリックコメント実施を推奨。	県計画でも市町村にパブコメ実施を推奨。	R9.2にパブリックコメント30日間実施予定。計画素案は町HPに掲載予定。	○ 整合	本町でも例規に基づきパブコメ実施。
【進行管理・評価】						
05-4	PDCAサイクル	国基本指針：計画期間中の毎年度PDCAサイクルによる進捗確認を求める。	県計画でも毎年度進捗確認、中間評価・最終評価の枠組みを推奨。	第8章 8-2でPDCAサイクル運用を明示。毎年度末評価＋R10年度中間評価＋R11年度末最終評価。	○ 整合	本町でも標準的PDCAサイクル採用。
05-5	KPI設定と評価	国基本指針：成果指標（KPI）の設定と毎年度進捗確認を求める。	県計画でも具体的KPI設定（数値目標）を推奨。	第5章・第6章で重点施策ごとにKPI設定。認知症は3層KPI（プロセス・アウトプット・アウトカム）。	○ 整合	本町は第10期で初の3層KPI採用（認知症）。
05-6	見える化システム登録	国基本指針：地域包括ケア「見える化」システムへの登録、他自治体との比較を推奨。	県計画でも見える化システム登録・活用を推奨。	見込量・保険料・KPI等を見える化システムに登録。仙南圏域他町と比較検証。	? 要確認	現在の登録状況・更新頻度を町担当課で確認。

05-7	計画期間中の見直し	国基本指針：計画期間中の制度改正・社会状況変化に応じた計画見直しを許容。	県計画でも必要に応じた市町村計画の見直しを推奨。	第8章 8-3で計画見直しの仕組みを明示。R10年度中間評価で見直し要否判断。	○ 整合	本町でも標準的見直しルール。
【関連計画との連携】						
05-8	上位・関連計画との整合	国基本指針：医療計画・障害福祉計画・地域福祉計画等との整合を求める。	県計画でも上位・関連計画との整合を推奨。	呂城県医療計画・健康かわさき21・データヘルス計画・地域福祉計画（ジャパン総研策定）・障害者計画（同）との整合を確認	△ 部分整合	地域福祉計画・障害者計画はジャパン総研策定。3計画同時策定での整合確認が課題。

06 確認事項・論点（ギャップ・対応必要事項の一覧）

——「△部分整合」「?要確認」「×未対応」項目の対応方針一覧——

No	シート	項目	現状	対応方針	対応期限	優先度
01	01_基本理念・基本目標	01-6 基本目標5包括センター強化（部分整合）	認定調査1名で業務量過多・ケアプラン外部委託で対応中	認定調査員増員検討、ICT導入で業務効率化、県モデル事業活用検討	R9策定中	B
02	02_重点施策	02-2 公共交通との連携（部分整合）	バス（地振課・町民生活課）と福祉部局（保健福祉課）の連	委員会協議事項3で取り上げ、所管調整・利用情報一元化を推進	R9策定中	A
03	02_重点施策	02-6 介護人材確保（部分整合）	本町独自の人材確保策は限定的、県事業（修学資金貸付）の活用が中心	県事業の周知強化、町内事業者連絡会を通じた実態把握・支援検討	R9策定中	B
04	02_重点施策	02-7 包括センター強化（部分整合）	保健師3+認定調査1名（社協運営）の体制	認定調査員増員検討、財政負担を勘案、県モデル事業活用	R9策定中	B
05	03_認知症施策推進計画	03-6 第20条 チームオレンジ（未対応）	本町ではチームオレンジ未整備	第10期で新規整備（J-2）。サポーター・キャラバンメイトからチーム員養成、人材確保が課題	R9-11	A
06	04_介護保険サービス・保険料	04-6 予定収納率（要確認）	過去5年間の収納率実績の集計が町担当課で進行中	町担当課から集計結果を入手次第、第10期予定収納率を確定	R8.7	A
07	04_介護保険サービス・保険料	04-7 介護給付費準備基金（要確認）	基金残高R8.6時点確定値が町担当課で集計中	町担当課からR8.6確定値を入手次第、3パターン試算精緻化に反映	R8.6	A
08	05_推進体制・KPI評価	05-6 見える化システム登録（要確認）	見える化システムの登録状況・更新頻度の確認が必要	町担当課で登録状況確認・必要に応じて更新・他自治体比較分析	R8.8	B
09	05_推進体制・KPI評価	05-8 関連計画との整合（部分整合）	地域福祉計画・障害者計画はジャパン総研策定で別ベンダー	ジャパン総研との情報共有・調整、3計画同時策定の整合確認	R9策定中	A

10	全シート	宮城県第10期支援計画の方向性（要確認）	宮城県第10期支援計画は令和8年度策定中、第9期版を参照中	宮城県第10期支援計画の素案・確定版を入手次第、整合性を再確認	R9.1まで	A
11	全シート	国通知（令和8年夏以降）の反映（要確認）	国の認知症基本法対応の通知・介護保険事業計画作成手引きの更新内容	通知発出後速やかに本計画素案に反映、変更点を委員会に報告	R8夏-秋	A

※ 本シートは01～05シートで「△部分整合」「?要確認」「×未対応」となった項目を抽出し、対応方針を一覧化したものです。
※ 優先度A（赤）は計画素案Ver.2.0更新（R8.8-9）までに対応必要、優先度B（青）は計画期間中に対応可能。
※ 委員会では本シートの内容を「3層整合確認の論点」として参考資料的に提示することを推奨します。